

低频电刺激与康复训练对小儿脑性瘫痪运动功能的影响

吴宗跃

(南阳市中心医院 儿科, 河南 南阳 473000)

摘要:目的 对应用康复训练与低频电刺激联合对患有脑性瘫痪的患儿实施治疗的临床效果进行研究。方法 选取 94 例患有脑性瘫痪的患儿, 随机分为对照组和治疗组, 各 47 例。采用单纯康复训练模式对对照组患儿实施治疗; 采用康复训练与低频电刺激联合对治疗组患儿实施治疗。结果 治疗组患儿脑性瘫痪病情治疗效果明显优于对照组; 治疗前后运动功能评分的改善幅度明显大于对照组; 运动功能改善时间和治疗方案实施总时间明显短于对照组。结论 应用康复训练与低频电刺激联合对患有脑性瘫痪的患儿实施治疗的临床效果非常明显。

关键词: 康复训练; 低频电刺激; 脑性瘫痪
中图分类号: R742.3

文献标识码: B

近年国内外相关文献报道显示, 对不同脑区进行仿生物电刺激可以使局部脑血流发生改变, 改善脑循环, 使处于缺血状态的脑组织灌流量明显增加^[1]。本次研究对患有脑性瘫痪的患儿在治疗过程中应用康复训练与低频电刺激联合的临床效果进行研究, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2011 年 3 月 -2013 年 3 月期间我院收治的 94 例脑瘫患儿, 随机分为对照组和治疗组。对照组中男 26 例, 女 21 例; 患儿年龄 4~72 个月, 平均年龄 (24.3±1.6) 个月; 患病时间 1~18 个月, 平均患病时间 (6.4±0.8) 个月; 治疗组中男 27 例, 女 20 例; 患儿年龄 6~73 个月, 平均年龄 (24.5±1.7) 个月; 患病时间 1~16 个月, 平均患病时间 (6.5±0.7) 个月。两组在年龄、性别、患病时间等自然指标方面进行组间比较 $P<0.05$, 差异均没有统计学意义, 数据可进行对比研究。

1.2 方法

对照组采用 Vojta 法及 Bobath 法实施康复训练, 1 次/d, 每次持续 50 min, 计划治疗一个月。治疗组在对照组基础上, 实施低频电刺激治疗, 每次持续 20 min, 1 次/d, 计划治疗一个月。

1.3 观察指标

选择两组患者的运动功能改善时间、治疗方案实施总时间、治疗前后运动功能评分的改善幅度、脑性瘫痪病情治疗效果等指标进行对比研究。

1.4 治疗效果评价方法

显效: 治疗后 GMFM 评分相应功能区的分数增加程度达到或超过 2 个标准差, 脑电图表现恢复或 CT 减产结果显示脑萎缩、脑软化灶程度明显减轻或转为正常; **有效:** 治疗后 GMFM 评分相应功能区的分数的增加程度达到或超过一个标准差, 但没有达到两个标准差, 脑电图表现明显好转或基本正常, 头部 CT 检查结果显示脑萎缩、脑软化灶程度有显著改善; **无效:** 治疗后 GMFM 评分相应功能区的分数没有任何增加表现, 脑电图、头部 CT 检查结果均没有任何改善, 或病情加重^[2]。

1.5 统计学方法

数据采用统计学软件 SPSS 18.0 进行处理, 采用 $\bar{x} \pm s$ 对所得所有计量资料进行表示, 计量资料进行 t 检验, 计数资料进行 χ^2 检验。

2 结果

2.1 治疗前后运动功能评分的改善幅度

对照组患儿接受康复训练治疗前 GMFM 评分为 (29.06±3.18) 分, 治疗后 GMFM 评分为 (38.05±3.04) 分,

组内差异显著 ($P<0.05$); 治疗组患儿接受康复训练与低频电刺激联合治疗前 GMFM 评分为 (28.75±2.41) 分, 治疗后 GMFM 评分为 (49.22±3.17) 分, 组内差异显著 ($P<0.05$)。两组患儿治疗前 GMFM 评分组间无显著差异 ($P>0.05$), 治疗后组间差异有显著统计学意义 ($P<0.05$)。

2.2 脑性瘫痪病情治疗效果

对照组采用康复训练模式治疗后, 15 例患儿的脑性瘫痪病情达到显效治疗标准, 20 例患儿的脑性瘫痪病情达到有效治疗标准, 12 例患儿的脑性瘫痪病情达到无效治疗标准, 该组患儿脑性瘫痪治疗总有效率为 74.5%; 治疗组采用康复训练与低频电刺激联合治疗后, 19 例患儿的脑性瘫痪病情达到显效治疗标准, 24 例患儿的脑性瘫痪病情达到有效治疗标准, 4 例患儿的脑性瘫痪病情达到无效治疗标准, 该组患儿脑性瘫痪治疗总有效率为 91.5%。两组患儿脑性瘫痪病情治疗效果组间差异有显著统计学意义 ($P<0.05$), 见附表。

附表 两组患儿脑性瘫痪病情治疗效果比较 (n, %)

组别	例数	显效	有效	无效	有效率
对照组	47	15(31.9)	20(42.6)	12(25.5)	35(74.5)
治疗组	47	19(40.4)	24(51.1)	4(8.5)	43(91.5)
P 值		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

2.3 运动功能改善时间和治疗方案实施总时间

对照组患儿采用康复训练模式治疗后 (16.44±2.43) d 运动功能得到改善, 治疗疗程共计实施 (23.24±3.81) d; 治疗组患儿采用康复训练与低频电刺激联合治疗后 (11.82±2.16) d 运动功能得到改善, 治疗疗程共计实施 (18.96±3.15) d。两组患儿运动功能改善时间和治疗方案实施总时间比较组间差异有显著统计学意义 ($P<0.05$)。

3 讨论

据相关文献报道, 在我国患有脑性瘫痪 (脑瘫) 的儿童的概率达到 1.8‰~6.0‰ 之间, 该类患儿的主要临床症状表现为中枢运动功能出现严重障碍, 及姿势存在明显异常, 该类疾病的康复治疗主要提倡采用在早期阶段实施多途径的综合治疗。Vojta 和 Bobath 创立的神经发育疗法主要是借助小儿的脑神经仍然处于生长发育阶段、可塑性相对较强这一基本特点, 以手法对异常姿势及运动模式进行控制, 并逐渐诱导患儿建立起正常的健康运动模式, 该方法已经成为临床对小儿脑瘫进行治疗的一个重要措施。小脑电刺激主要是应用数字频率合成仿生物电技术, 对患儿的神经系统进行良性刺激, 进而使脑部的血液循环情况得到显著改善^[3]。

参 考 文 献

- [1] 史惟, 廖元贵, 杨红, 等. 粗大运动功能测试量表与 Peabody 粗大运动发育量表在脑性瘫痪康复疗效评估中的应用 [J]. 中国康复理论与实践, 2009, 10(7): 424.

收稿日期: 2013-12-02

760例女性淋病临床观察与分析

陈俞霖

(长沙医学院第一附属医院 皮肤性病科, 湖南 长沙 410219)

摘要:目的 对女性淋病进行观察及分析, 探究女性淋病的治疗方法 & 诊断方法。方法 随机选取我院 2009 年 1 月 - 2013 年 7 月期间所收治的 760 例女性淋病患者, 回顾性分析女性淋病 760 例患者的临床资料。结果 经淋球菌培养可知, 760 例患者均为阳性; 64 例新生儿淋菌性结膜炎, 116 例幼女外阴淋菌性阴道炎, 374 例淋菌性宫颈炎, 148 例淋菌性尿道炎, 58 例淋菌性前庭大腺脓肿; 经临床治疗, 女性淋病 760 例患者均得以治愈出院。结论 淋病筛查的金标准就是淋球菌培养, 临床上要进行淋球菌培养对疑似病例, 以便于减少漏诊, 提高确诊率; 在治疗的过程中, 应当遵循合理、彻底、尽早的原则, 防止耐药菌株的产生, 以促进治愈率的提高。

关键词: 淋球菌培养; 女性淋病; 治疗
中图分类号: R759.2

文献标识码: B

淋病是一种阴性革兰双球菌, 是奈瑟淋菌双球菌所导致的, 适宜在含有 CO_2 且温度介于 35°C ~ 36°C 的潮湿环境中生长, 而在完全干燥的环境下 1~2 h 便会死亡, 在 100°C 能立刻死亡, 50°C 可存活 30 min, 39°C 可存活 13 h。目前, 淋病是有着最高发病率的性传播疾病, 其所侵袭的主要是移行上皮以及柱状上皮的泌尿生殖道, 发病的主要部位是尿道、肛门、宫颈管、直肠下部黏膜、尿道旁腺以及前庭大腺等, 而生殖道鳞状上皮则对淋病有着一定的抵御能力^[1]。本文回顾性分析了本院 2009 年 1 月 - 2013 年 7 月期间所收治的 760 例女性淋病患者的临床资料, 旨在促进女性淋病患者的身体健康的恢复, 现如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取本院 2009 年 1 月 - 2013 年 7 月期间所收治的 760 例女性淋病患者, 患者的最大年龄为 63 周岁, 最小年龄为 3 d; 64 例新生儿, 116 例幼女, 540 例介于 20~35 周岁之间, 28 例介于 36~50 周岁之间, 12 例介于 50~63 周岁之间; 534 例患者已婚, 226 例患者未婚。

1.2 病史特点

在成年女性 580 例患者中, 有不洁性生活史的有 560 例, 其中, 有 408 例疑似伴侣或者配偶有淋病而要求确诊; 原因不明的有 20 例, 通过对病史的询问, 有在个体诊所进行妇科检查及人流史; 116 例幼女及 64 例新生儿, 因其母亲患有淋球菌尿道炎及宫颈炎而患病, 培养宫颈分泌物为阳性。

1.3 临床特征

白带增多且呈现脓性, 持续 2 周至 3 个月的时间, 并且伴有排尿困难、尿痛以及尿频等临床症状^[2]。116 例患者外阴肿痛、外阴瘙痒、尿道口及处女膜口有脓性分泌物且红肿, 占据总体的 15.26%; 64 例眼部出现脓性分泌物, 占据总体的 8.42%; 374 例脓性白带、宫颈及阴道黏膜水肿充血、宫颈口糜烂, 占据总体的 49.21%; 148 例有泌尿系刺激症状, 比如尿痛、尿频、尿道口黏膜充血; 58 例前庭大腺肿痛充血且有脓液, 占据总体的 7.63%。

1.4 检验方法

为了提高治疗效果, 明确诊断且找出耐药菌株, 对 760 例女性淋病患者进行淋球菌培养, 检测艾滋病、衣原体和支原体, 同时对 580 例成年女性进行药物敏感试验。在采选标本上, 按照患者的发病部位、临床表现和年龄等, 来对合适的标准加以选用。

1.5 治疗方法

在新生儿淋病治疗上, 要实行住院隔离治疗, 采用 $10\text{万 U} \cdot \text{kg}^{-1}$ 至 $20\text{万 U} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的青霉素进行静脉滴注, 维持 7~10 d 的治疗时间, 并且使用生理盐水对双眼进行清洗, 每隔 1 小时清洗 1 次, 冲洗后再使用比例为 1:50000 U 的青霉素溶液亦或是 0.5% 浓度的红霉素液进行滴眼, 同样维持 7~10 d; 在幼女淋病患者的治疗上, 首选 125 mg 的头孢三嗪或者 $10\text{万 U} \cdot \text{kg}^{-1}$ 至 $20\text{万 U} \cdot \text{kg}^{-1}$ 的青霉素进行一次肌注, 如果对头孢菌素及青霉素过敏, 则可更改为大观霉素^[3]。采用 1:5000 比例的高锰酸钾来进行局部处理, 早晚分别 1 次浸洗, 直到不良症状消退; 对于成年女性淋病患者的治疗, 如果是对头孢类药物较为敏感的患者, 每天肌注 1 g 头孢曲松, 并且对 0.5 g 的红霉素加以口服, 每天 4 次, 一个疗程 7~10 d。如果是对青霉素过敏的患者, 则需要每天肌注 2 g 大观霉素, 治疗过程同上。如果是合并滴虫感染的患者, 应当每天再口服 0.4 g 的甲硝唑。同时治疗性伴侣或配偶的淋病。

2 结果

按照淋球菌培养结果、临床表现和病史, 760 例患者均得以明确诊断, 其中, 64 例新生儿淋菌性结膜炎, 116 例幼女外阴淋菌性阴道炎, 374 例淋菌性宫颈炎, 148 例淋菌性尿道炎, 58 例淋菌性前庭大腺脓肿; 经临床治疗, 女性淋病 760 例患者均得以治愈出院。

3 讨论

在本研究中的 760 例女性淋病患者中, 64 例新生儿淋菌性结膜炎, 116 例幼女外阴淋菌性阴道炎, 374 例淋菌性宫颈炎, 148 例淋菌性尿道炎, 58 例淋菌性前庭大腺脓肿。经过有针对性的临床治疗, 760 例患者均得以成功治愈。总之, 淋球菌培养可谓是诊断淋病的一大金标准, 医务人员应当积极的应用推广, 并且切实的做到早诊断、早治疗, 以减轻患者的病痛, 提高患者的身体健康水平。

参考文献

- [1] 农宝安, 陆袖珍. 隆安县 392 例女性淋病患者检测及治疗回顾性分析 [J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2010, 15(8): 20-21.
- [2] 许文静. 女性淋病患者的治疗 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2013, 2(7): 89-90.
- [3] 庞东彦. 女性淋病 82 例门诊治疗 [J]. 右江民族医学院学报, 2008, 3(19): 15-16.

收稿日期: 2013-11-18

[2] 陈秀洁, 李晓捷. 小儿脑性瘫痪的神经发育学治疗法 [M]. 郑州: 河南科学技术出版社, 2010: 112.

[3] 周洪语, 沈建康, 罗其中. 电刺激小脑顶核治疗缺血性脑损害 [J]. 国外医学脑血管疾病分册, 2010, 8(4): 218.